

Rapport mondial sur les maladies tropicales négligées 2025

Dengue et chikungunya
Dracunculose
Échinococcose
Envenimation par morsure de serpent
Filariose lymphatique
Gale et autres ectoparasitoses
Géohelminthiases
Leishmaniose
Lèpre
Maladie de Chagas
Mycétome, chromoblastomycoses et autres mycoses profondes
Noma
Onchocercose
Pian
Rage
Schistosomiase
Taeniasis et cysticercose
Trachome
Trématodoses d'origine alimentaire
Trypanosomiase humaine africaine
Ulcère de Buruli

Résumé d'orientation

En 2025, le Programme mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées fête ses 20 ans. Depuis sa création en 2005, il agit et recueille des données, et un effort concerté auquel participent des fabricants de produits pharmaceutiques, des partenaires de développement, des organisations philanthropiques, des autorités sanitaires nationales et l'OMS, a contribué à une baisse mesurable de la charge mondiale de morbidité et mortalité attribuable aux maladies tropicales négligées (MTN).

Ce rapport présente les progrès accomplis en 2023–2024 en vue d'atteindre les cibles fixées pour 2030 dans le document intitulé *Lutter contre les maladies tropicales négligées pour atteindre les objectifs de développement durable : feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021–2030* (la Feuille de route), et plusieurs analyses actualisées :

- Progrès accomplis vis-à-vis de l'ensemble des indicateurs, jalons et cibles globaux, transversaux et spécifiques à chaque maladie.
- Analyse de la charge de morbidité en termes d'années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY), de prévalence et de mortalité, ainsi que du nombre de personnes touchées par les MTN, détectées et traitées.
- Nouvelles perspectives concernant le risque financier associé aux MTN, mettant en évidence le fait que ces maladies appauvrissent les populations touchées.
- Examen détaillé de quatre domaines thématiques – outils de diagnostic, suivi et évaluation, accès et logistique, plaidoyer et financement – grâce à l'outil d'évaluation des lacunes [Gap Assessment Tool, GAT].
- Analyse de l'aide publique au développement pour les MTN, compte tenu des contraintes financières et de l'évolution de la situation.

Résultats globaux

En 2023, on estime que 1,495 milliard de personnes ont nécessité des interventions contre les MTN, soit 122 millions de moins qu'en 2022 ou une baisse de 32 % par rapport au niveau de référence de 2010. Entre 2015 et 2021, la charge de morbidité est passée de 17,2 millions à 14,1 millions de DALY, tandis que le nombre de décès liés aux MTN est passé d'environ 139 000 à 119 000. Le nombre de personnes touchées par les MTN est passé de 1,9 milliard en 1990 à un peu plus d'un milliard en 2021.

En 2023, 867,1 millions de personnes ont été traitées pour une MTN au moins, 99 % d'entre elles par des interventions de chimiothérapie préventive.

En 2024, l'OMS a confirmé l'élimination d'une MTN dans sept pays (le Brésil et le Timor-Leste pour la filariose lymphatique ; le Tchad pour la trypanosomiase humaine africaine à *T. b. gambiense* ; l'Inde, le Pakistan et le Viet Nam pour le trachome ; et la Jordanie pour la lèpre), ce qui porte à 54 le nombre pays d'où une MTN au moins a été éliminée et à 75 le nombre de processus de confirmation achevés.

Des améliorations notables ont été observées pour plusieurs indicateurs transversaux, y compris l'intégration accrue de la mise

en œuvre de la chimiothérapie préventive, comme en témoigne l'amélioration de l'indice de couverture des traitements intégrés. Des progrès supplémentaires ont été enregistrés dans l'adoption plus large de stratégies intégrées de lutte contre les MTN à manifestation cutanée, la meilleure prise en compte des MTN dans les stratégies, les plans et les ensembles de services essentiels nationaux de santé, et l'adoption plus large de lignes directrices pour la prise en charge des handicaps liés aux MTN. Néanmoins, on constate un ralentissement ou une stagnation des progrès dans plusieurs domaines essentiels : la baisse du nombre de décès dus aux maladies à transmission vectorielle, l'élargissement de l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, la protection de la population contre les dépenses directes catastrophiques, l'établissement de rapports complets sur toutes les MTN et la collecte de données ventilées par genre.

Maladies à éradiquer

En 2024, 15 cas humains de **dracunculose (maladie du ver de Guinée)** ont été signalés dans deux pays seulement (le Soudan du Sud et le Tchad). Toutefois, des cas ont encore été détectés chez les animaux dans ces deux et quelques autres pays.

À la fin de l'année 2024, le **pian** restait endémique dans 16 pays de trois Régions de l'OMS. En outre, il faut réévaluer la situation de 82 pays où le pian était auparavant endémique.

Le début d'un processus menant à la création d'une commission mixte pour la certification de l'éradication de la dracunculose et du pian, en 2024, est une avancée importante.

Maladies à éliminer (interruption de la transmission)

En 2023, 10 pays ont notifié à l'OMS 675 cas de **trypanosomiase humaine africaine à *T.b. gambiense***. Au total, cette maladie reste endémique dans 24 pays, tandis que son élimination en tant que problème de santé publique a été confirmée dans sept pays ; l'interruption de la transmission n'a encore été vérifiée dans aucun de ces pays.

En 2023 également, 184 pays, territoires et zones ont communiqué à l'OMS des données sur la **lèpre**, ce qui constitue l'un des meilleurs résultats en termes de notification concernant les MTN ; 56 de ces pays n'ont signalé aucun cas. En 2024, la Jordanie est devenue le premier pays où l'élimination de la lèpre a été vérifiée.

En 2024, plusieurs pays étaient sur le point d'arrêter l'administration massive de médicaments (AMM) contre l'**onchocercose** et de passer à la surveillance post-thérapeutique. En 2023, 172 millions de personnes ont été traitées à l'ivermectine pour cette maladie, ce qui est le nombre annuel le plus élevé à ce jour.

Maladies à éliminer en tant que problème de santé publique

À la fin de l'année 2024, huit pays (l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'État plurinational de Bolivie, le Paraguay, le Pérou

et l'Uruguay) avaient interrompu la transmission domiciliaire du vecteur de la **maladie de Chagas** sur l'ensemble de leur territoire national ou dans certaines zones.

En 2023, quatre pays (l'Éthiopie, le Malawi, la République-Unie de Tanzanie et la Zambie) ont signalé 24 cas de **trypanosomiase humaine africaine à *T. b. rhodesiense***, ce qui représente une baisse de 96,6 % par rapport à 2000.

Bien que le nombre de cas de **leishmaniose viscérale** soit resté stable au cours des quatre dernières années, on constate une baisse importante depuis 2014, principalement en raison des progrès réalisés dans la Région de l'Asie du Sud-Est.

En 2023, la couverture de l'AMM contre la **filariose lymphatique** est revenue aux niveaux d'avant la pandémie de COVID-19, en partie car 137 millions de personnes de moins qu'en 2022 avaient besoin de cette intervention.

L'amélioration de la collecte de données sur la **rage** a entraîné une augmentation significative du nombre de décès signalés en 2022–2023 par rapport aux années précédentes. Néanmoins, la sous-notification reste un gros problème.

Le nombre de personnes qui avaient besoin d'une chimiothérapie préventive pour la **schistosomiase** a diminué de 11,3 millions entre 2022 et 2023. Cependant, des lacunes de la couverture thérapeutique persistent, en particulier chez les adultes.

Les progrès dans le traitement des **géo-helminthiases** sont restés stables. Le traitement de masse de ce groupe de maladies, dont ont bénéficié plus de 457 millions de personnes en 2023, reste l'une des interventions de santé publique de plus grande ampleur au monde. En 2024, l'OMS a publié ses premières lignes directrices sur la **strongyloïdose** afin d'intensifier la lutte contre cette maladie du point de vue de la santé publique.

En 2024 également, l'OMS a validé l'élimination du **trachome** en tant que problème de santé publique dans trois pays (l'Inde, le Pakistan et le Viet Nam). Le nombre de personnes nécessitant des interventions contre cette maladie a été ramené à 114 millions en 2023, contre plus de 285 millions en 2010.

Maladies à contrôler

Les moyens de diagnostic de l'**ulcère de Buruli** sont renforcés à l'échelle mondiale, comme en témoigne la proportion croissante de cas confirmés en laboratoire. Cependant, les progrès concernant la détection des cas et l'achèvement des traitements restent lents.

Le nombre de cas de **dengue** a continué d'augmenter ces dernières années. En 2024, l'OMS a classé la dengue comme urgence de niveau 3 (le niveau d'urgence le plus élevé) et a préqualifié un nouveau vaccin contre la dengue.

Les démarches visant à cartographier le **chikungunya** se poursuivent, bien que la notification reste limitée. Les stratégies et les outils de lutte contre cette maladie sont actuellement renforcés.

Le nombre de cas d'**échinococcose** notifiés a augmenté en 2023 par rapport à 2022. Cependant, la sous-notification reste

un gros problème. Quelques pays ont commencé à intensifier leurs efforts de lutte.

La chimiothérapie préventive des **trématodoses d'origine alimentaire** n'est mise en œuvre que dans un petit nombre de pays, la notification restant minime. En 2024, l'OPS a publié des lignes directrices opérationnelles pour l'élimination de la fasciolose humaine en tant que problème de santé publique dans les Amériques.

Ces dernières années, le nombre de cas de **leishmaniose cutanée** a augmenté, en grande partie à cause des perturbations que connaissent les systèmes de santé dans la Région de la Méditerranée orientale. Néanmoins, l'amélioration de la notification dans les Amériques a permis de constater que la détection et la prise en charge des cas progressaient dans plusieurs pays.

Le **mycétome**, la **chromoblastomycose**, la **paracoccidioïdomycose** et la **sporotrichose** restent parmi les affections les plus négligées. Le manque d'informations empêche encore d'apprécier pleinement leur charge de morbidité et leur répartition, et les progrès dans l'intégration de ces maladies dans les programmes de santé publique restent lents.

Bien que l'on ne connaisse toujours pas exactement la charge de morbidité du **noma**, son inscription sur la liste des MTN en décembre 2023 est encourageante. Depuis lors, le processus d'intégration du noma dans la Feuille de route et la collecte de données ont commencé.

Les cas de **gale** et d'autres ectoparasitoses, comme la **tungose**, restent sous-notifiés. Cependant, certains pays ont commencé à inclure ces affections dans les plans de lutte contre les MTN ou dans les soins entrant dans la couverture sanitaire universelle, et ont mis en œuvre des activités de lutte telles que l'administration de masse d'ivermectine.

Quelques progrès ont été constatés en ce qui concerne les **envenimations par morsure de serpent**. Leur déclaration est désormais obligatoire dans certains pays, des lignes directrices nationales sur leur traitement ont été établies ou mises à jour et les possibilités de production locale de sérums antivenimeux sont étudiées ou évaluées.

En 2024, un cadre de suivi et d'évaluation concernant la lutte contre le **taeniasis** et la **cysticercose** à des fins de santé publique a été lancé pour orienter la cartographie et l'évaluation de l'impact.

Les MTN ne sont toujours pas assez prises en compte. Le manque de données de qualité, actualisées et complètes freine encore considérablement les progrès dans la lutte contre l'ensemble des MTN. Plusieurs maladies sont difficiles à diagnostiquer cliniquement ou nécessitent des analyses en laboratoire spécialisées. Les systèmes de surveillance et de notification sont souvent fragiles, voire inexistantes, et certaines maladies sont historiquement exclues des systèmes nationaux d'information sanitaire. Dans de nombreux endroits, le recours aux guérisseurs traditionnels ou à des prestataires informels est courant, ce qui réduit encore plus la visibilité.

Le renforcement de la surveillance, l'intégration des MTN dans les systèmes nationaux d'information sanitaire de routine et

la réduction de la fragmentation des dispositifs de notification sont essentiels pour suivre avec précision les progrès et faire en sorte que les interventions soient efficaces et durables.

Action programmatique

La mise en œuvre de la Feuille de route a progressé à plusieurs égards en 2024 :

- **Innovation technique** : l'OMS a lancé un processus de définition des priorités de la recherche-développement pour les MTN ; six nouvelles formulations de médicaments contre les MTN ont été préqualifiées par l'OMS, ce qui porte à 20 le nombre total de produits pharmaceutiques finis contre les MTN préqualifiés par l'OMS ; un ingrédient pharmaceutique actif pour la miltéfosine et un nouveau vaccin contre la dengue ont également été préqualifiés.
- **Activités normatives** : une cinquantaine de publications de l'OMS ont permis d'actualiser les programmes en fonction des dernières orientations : il s'agit notamment de deux séries de lignes directrices, l'une sur la trypanosomiase humaine africaine et l'autre sur la strongyloïdose ; d'un cadre de suivi et d'évaluation de la schistosomiase et des géohelminthiases ; d'un cadre stratégique régional pour mettre fin aux MTN en Asie du Sud-Est ; d'un cadre stratégique pour éliminer la leishmaniose viscérale en Afrique de l'Est ; et d'une série de lignes directrices opérationnelles pour l'élimination de la fasciolose humaine en tant que problème de santé publique dans les Amériques. En outre, six profils de produits cibles ont été publiés en 2024 : cinq sur des outils de diagnostic et un sur les antivenins contre les morsures de serpent, ce qui porte à 27 le nombre de profils de produits cibles de l'OMS pour les MTN.
- **Soutien opérationnel** : à la fin de l'année 2024, 12 fabricants avaient fait don de 19 types de médicaments différents pour soutenir les interventions contre les MTN ; entre 2011 et 2024, près de 30 milliards de comprimés et de flacons ont été livrés aux pays, dont 1,8 milliard ont été donnés et livrés pour des traitements effectués en 2024 ; le Comité mondial pour la coordination et la bonne gestion [*Global Coordination and Stewardship Committee*] a été créé pour assurer la gestion efficace des médicaments contre les MTN dont il est fait don à l'échelle mondiale et régler les problèmes liés à la chaîne logistique dans les pays ; un projet pilote quinquennal, le Mécanisme d'appui technique à la chaîne logistique [*Supply Chain Technical Support Mechanism*], a été lancé dans huit pays africains prioritaires (Éthiopie, Kenya, Madagascar, Mozambique, Nigéria, Ouganda, République démocratique du Congo et République-Unie de Tanzanie).
- **Plaidoyer et partenariats** : les MTN ont à nouveau été évoquées dans des instances mondiales, telles que le G7 et le G20. L'appel mondial pour éliminer la discrimination à l'encontre des personnes touchées par la lèpre, organisé par la Fondation Sasakawa pour la Santé [*Sasakawa Health Foundation*], a eu lieu au Siège de l'OMS à Genève en 2024 ; une réunion internationale de haut niveau sur l'éradication de la dracunculose s'est tenue au Tchad les 16 et 17 septembre 2024 ; l'OMS a établi de nouveaux partenariats avec Gavi, l'Alliance du vaccin (sur la rage) et

le Fonds pour les technologies novatrices en faveur de la santé dans le monde [Global Health Innovative Technology Fund, GHIT], afin de favoriser l'accès à des médicaments, des vaccins et des outils de diagnostic sûrs, abordables et efficaces pour les MTN.

- **Renforcement des capacités :** en 2024, l'OMS a élargi son offre de cours en ligne sur les MTN en publiant 33 nouveaux produits couvrant 23 sujets techniques, en sept langues ; entre 2020 et 2024, l'OMS a publié au total 102 cours couvrant 37 sujets différents relatifs aux MTN, dans 15 langues. Entre juin et octobre 2024, l'application de l'OMS sur les MTN à manifestation cutanée [WHO Skin NTDs App], basée sur l'IA, a été évaluée pour la première fois au Kenya.
- **Approches transversales :** les démarches visant à renforcer l'intégration mutuelle des services de lutte contre les MTN, à favoriser la coordination intersectorielle et à faciliter l'intégration dans les systèmes de santé nationaux se sont poursuivies, en particulier dans le cadre des initiatives visant à éliminer plusieurs maladies [multi-disease elimination] et à rendre les campagnes sanitaires plus efficaces [health campaign effectiveness]. L'intégration des activités de lutte et de prise en charge liées aux MTN à manifestation cutanée témoigne de cette évolution vers des modèles de prestation centrés sur la personne et vers les soins de santé primaires. Parallèlement, les travaux visant à faciliter l'intégration des données sur les MTN dans les systèmes d'information pour la gestion sanitaire ont progressé dans le cadre de l'initiative de l'OMS sur les systèmes d'information sanitaire de routine [WHO Routine Health Information System (RHIS) toolkit initiative]. Des mesures ont également été prises pour rationaliser et harmoniser les approches de collecte de données sur les MTN, y compris les processus, les plateformes et les formulaires de notification.
- **Changements climatiques :** face aux risques liés au climat, l'Équipe spéciale de l'OMS sur les changements climatiques, les maladies tropicales négligées et le paludisme [WHO Task Team on Climate Change, Neglected Tropical Diseases and Malaria] a procédé à un examen exhaustif dans ce domaine, qui a montré que l'impact potentiel des changements climatiques sur les MTN est toujours mal compris et a souligné la nécessité de poursuivre les travaux de recherche ; en outre, l'OMS a publié un plan mondial de préparation et de riposte à la dengue et à d'autres arboviroses transmises par les moustiques du genre *Aedes*, qui propose un modèle de prise en charge des maladies sensibles au climat fondé sur une action intersectorielle.
- **Suivi des performances :** une évaluation qualitative des progrès accomplis dans l'atteinte des cibles énoncées dans la Feuille de route a été réalisée grâce à l'outil d'évaluation des lacunes [GAT]; les résultats ont permis de repérer les principaux besoins et les principales priorités pour quatre des 11 dimensions de la Feuille de route – outils de diagnostic, suivi et évaluation, accès et logistique, et plaidoyer et financement – couvrant à la fois des domaines spécifiques à une maladie et des domaines transversaux.
- **Genre, équité et droits humains :** la sensibilisation fondée sur les droits a gagné du terrain à l'Assemblée mondiale de

la Santé, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et à l'Assemblée générale des Nations Unies, en mettant l'accent sur la sécurité des pesticides dans le contexte de la santé des peuples autochtones et sur la discrimination à l'encontre des personnes touchées par la lèpre et des membres de leur famille. L'OMS a défendu l'extension de l'approche axée sur le genre, l'équité et les droits humains à toutes les MTN.

Tendances en matière de pérennité et de financement

En 2024, 14 pays africains avaient établi des plans nationaux de développement durable dans le cadre de processus dirigés par les pouvoirs publics, avec le soutien de partenaires. Ces plans ont facilité les démarches déployées au niveau national pour améliorer les compétences, renforcer les capacités et mobiliser des ressources afin de fournir durablement des services de lutte contre les MTN, d'accroître la visibilité nationale des MTN et de favoriser la collaboration multisectorielle.

L'aide publique au développement consacrée aux MTN a diminué de 41 % entre 2018 et 2023, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une réduction de la marge de manœuvre budgétaire. Il est donc d'autant plus nécessaire d'établir des priorités, de mobiliser des ressources nationales et de privilégier stratégiquement les interventions à fort impact.

Perspectives

Bien que les programmes de lutte contre les MTN aient continué de progresser en 2023–2024, les performances restent inégales selon les maladies et les domaines. Les changements climatiques contribuent encore à la propagation des MTN à transmission vectorielle et de nouvelles régions. Les conflits géopolitiques, les migrations, les crises humanitaires et l'instabilité perturbent l'accès aux interventions et aux services de lutte contre les MTN. Les lacunes persistantes en matière de données et la fragilité des systèmes de surveillance compromettent la planification stratégique et la gestion courante des programmes. Il est important de noter qu'en l'absence de mécanismes de financement qui permettent aux pays d'avoir la maîtrise de la situation et de mobiliser les communautés touchées, il y a un risque réel de stagnation des progrès durement obtenus, voire de régression.

Les cinq ans qui nous séparent de 2030 seront probablement marqués par un contraste plus net entre les problèmes décrits ci-dessus et la nécessité de maintenir l'élan à mesure que les pays s'approchent des cibles en matière d'élimination et d'éradication. Pour atteindre les objectifs de la feuille de route d'ici à 2030, les programmes doivent rester très ciblés, privilégier les mesures essentielles et exploiter pleinement les possibilités d'intégration et d'innovation. La planification stratégique pour la période 2025–2030 sera essentielle pour faire face aux crises des systèmes de santé, consolider les progrès, maintenir les acquis et réaliser pleinement les ambitions inscrites dans la Feuille de route.